壊死性筋膜炎患者の組織培養より結核菌を検出した一例

◎佐々木 崇寿[1)]、近藤 周平[1)]、大池 知行[1)]、井上 貴子[1)]
名古屋市立大学病院[1)]

【はじめに】結核菌は重篤な呼吸器感染症の原因菌であるが、皮膚軟部組織感染症の原因となることは稀である。今回、結核菌が関与したと考えられた壊死性筋膜炎（NF）の一例を経験したため報告する。

【症例】40 代女性。皮膚筋炎および間質性肺炎の既往があり、プレドニゾロン（PSL）20 mg で治療中であった。入院 11 日前より右上腕の発赤・腫脹を認め、右上腕丹毒の診断で入院した。セファゾリン、クリンダマイシン、ダプトマイシンで治療を開始し、血液と皮膚の培養が提出された。血液培養は陰性、皮膚培養では増菌培養で大腸菌を検出したが、丹毒の原因菌は特定できなかった。第 10 病日に皮膚所見の増悪を認め、皮膚筋炎の悪化によるものと判断され PSL は 60 mg に増量された。抗菌薬投与を継続していたが、第 17 病日頃より右上腕の壊死範囲が急速に拡大した。第 21 病日の試験切開で排膿を認め、NF と診断された。緊急切開排膿術を施行したが改善乏しく、第 25 病日に追加切開術を行った。

【検査所見】皮膚切開時に採取された組織は、一般細菌検査として提出された。第 21 病日の検体では鏡検で菌を認めなかった。第 25 病日の検体では、グラム染色で染まらない桿状構造物を多数確認したため、チール・ネルゼン染色を実施したところ、抗酸菌を 3＋ 認めた。PCR 検査を実施した結果、結核菌が陽性となった。翌日提出された喀痰からも蛍光塗抹±、PCR 検査で結核菌を検出した。なお前医での検査で T-SPOT 陽性であったため、入院前に 3 連痰の抗酸菌検査および T-SPOT を実施していたが、いずれも陰性であった。

【考察】本症例は T-SPOT 陽性歴があり、入院前の喀痰検査は陰性で潜在性結核感染症と推察されたが、未治療であった。PSL 増量に伴う免疫抑制により結核菌が肺で再活性化し、血行性またはリンパ行性に右上腕へ波及して NF を発症した可能性が高い。免疫抑制状態の患者で急速進行する NF を認めた場合、一般細菌のみならず抗酸菌感染も念頭に置いた検査が必要である。

【連絡先】052-851-5511(内線：2121)